

BỆNH ÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ tên bệnh nhân: ĐỖ THỊ L.
2. Tuổi: 61
3. Giới tính: Nữ
4. Nghề nghiệp: Nội trợ
5. Địa chỉ: Thị xã Núi Thành- huyện Núi Thành- Quảng Nam
6. Ngày vào viện: 8h ngày 21/06/2021
7. Ngày làm bệnh án: 14h ngày 25/06/2021

II. BỆNH SỬ

1. Lý do vào viện: Mệt mỏi, tiểu nhiều
2. Quá trình bệnh lý:

Cách nhập viện 2 tháng, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sụt cân (5kg/2 tháng). Cách nhập viện 3 ngày, bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, kèm theo uống nhiều, tiểu nhiều. Bệnh nhân có tự điều trị bằng nước lá không rõ loại. Sáng ngày nhập viện, mệt mỏi tăng nhiều nên bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam, tại đây bệnh nhân được xét nghiệm HbA1C 12.2% nên được cho nhập viện điều trị.

Tình trạng lúc nhập viện:

- Bệnh tình, tiếp xúc tốt
- Da niêm mạc hồng nhạt
- Sinh hiệu:
 - Mạch: 85 lần/phút
 - Nhiệt: 37 C
 - Huyết áp: 120/80 mmHg
 - Nhịp thở: 20 lần/phút

- Không phù, không xuất huyết dưới da, không tuần hoàn bàng hệ
- Tim đều, T1, T2 nghe rõ
- Phổi thông khí rõ
- Bụng mềm, không điểm đau

Chẩn đoán: Đái tháo đường type 2

Bệnh nhân được chuyển lên khoa Nội Tim mạch- Nội tiết để tiếp tục theo dõi và điều trị

III. TIỀN SỬ

1. Bản thân:

* Bệnh lý:

- Đái tháo đường type 2 chẩn đoán 3 năm, tái khám đều, hiện đang dùng 3 thuốc hạ đường huyết không rõ loại.
- Tăng huyết áp 1 năm, tái khám đều, hiện đang dùng Amlodipin 5mg/ngày.

* Thói quen:

- Không hút thuốc lá, không uống bia rượu
- Ít stress, ít lo lắng

* Thuốc: Tái khám và lấy thuốc thường xuyên tại bệnh viện, gần đây uống nước lá không rõ loại

* Dị ứng: Chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc, thức ăn

2. Gia đình

- Hiện đang sống với chồng bị đái tháo đường type 2 # 5 năm, biến chứng tắc động mạch chi P đã cắt cụt
- Mẹ bị ĐTĐ type 2

IV. LƯỢC QUA CÁC CƠ QUAN

1. Tim mạch: không đau ngực, không hồi hộp đánh trống ngực
2. Hô hấp: không ho, không khó thở
3. Tiêu hóa: không đau bụng, tiêu phân vàng đóng khuôn
4. Thận- tiết niệu: tiểu vàng trong, không gắt buốt
5. Thần kinh: không đau đầu, không chóng mặt
6. Cơ xương khớp: không đau nhức xương khớp

V. KHÁM LÂM SÀNG: 8h ngày 25/06/2021

1. Tổng trạng

- Bệnh tình, tiếp xúc tốt
- Sinh hiệu:
 - Mạch: 80 lần/phút
 - Huyết áp: 120/80 mmHg
 - Nhiệt độ: 37 C
 - Nhịp thở : 20 lần/phút
- Cân nặng: 61 kg, chiều cao: 158 cm -> BMI: 24.4 kg/m² : thừa cân
- Chi ấm, mạch rõ
- Da niêm mạc hồng, không xuất huyết da niêm
- Không phù
- Hạch ngoại biên không sờ chạm

2. Khám các cơ quan

a. Đầu mặt cổ

- Tuyến giáp không to, khí quản không lệch
- Tĩnh mạch cổ không nổi ở tư thế nằm
- Hạch cổ không sờ chạm

b. Ngực:

- Lồng ngực cân đối, di động theo nhịp thở
- Không sẹo mỗ cũ

* Tim:

- Mỏm tim khoảng liên sườn V trung đòn trái, diện đập mỏm tim $1 \times 1 \text{ cm}^2$
- Không dấu Hazer, không dấu nẩy trước ngực
- T1, T2 đều rõ, tần số 80 lần/phút, không nghe âm thổi

* Phổi

- Rung thanh đều 2 bên
- Gõ trong
- Rì rào phế nang nghe rõ, không nghe rales

c. Bụng

- Bụng cân đối, di động theo nhịp thở, không bất thường thành bụng
- Bụng mềm, không điểm đau khu trú
- Gan lách không sờ thấy
- Ấn điểm niệu quản trên, giữa không đau
- Nhu động ruột 7 lần/phút, không âm thổi

d. Cơ xương khớp

- Các khớp vận động trong giới hạn bình thường
- Sức cơ 5/5 các chi

e. Thần kinh

- Glasgow 15 điểm
- Cổ mềm, không dấu màng não
- Chưa phát hiện bất thường 12 đôi dây thần kinh sọ
- Không có dấu thần kinh khu trú
- Không rối loạn cảm giác

f. Khám mắt: không mờ, không giảm thị trường 2 bên mắt

g. Nội tiết:

- Khám bàn chân đái tháo đường
 - Không ghi nhận vết thương ở 2 chân
 - Khám mạch máu: 2 chân ấm, mạch mu chân, mạch chày sau 2 bên đều, rõ
- Phân bố lông bình thường, móng mắt nóng dễ gãy
- Da khô, ngứa toàn thân

VI. TÓM TẮT BỆNH ÁN

Bệnh nhân nữ 61 tuổi, nhập viện lúc ngày 21/06/2021 vì mệt mỏi, tiểu nhiều, có các bất thường sau:

- TCCN:
 - + Mệt mỏi
 - + Khát nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều
 - + Sụt 5kg/ 2 tháng
 - + Da khô, ngứa toàn thân
- TCTT:
 - + Glucose bất kì: 17.4 mmol/L
 - + HbA1c: 12.2%
 - + BMI: 24.4 kg/m²
- Tiền căn: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, uống nước lá không rõ loại

VII. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Chẩn đoán sơ bộ:

Bệnh chính: Đái tháo đường type 2

Bệnh kèm: Tăng huyết áp

2. Chẩn đoán phân biệt

Cường giáp

3. Biện luận:

- Bệnh nhân nữ 61 tuổi vào viện vì mệt mỏi, sụt cân (sụt 5kg/2 tháng) tiểu nhiều, xét nghiệm HbA1C : 12.2%, Glucose bất kỳ 17.4% thỏa mãn tiêu chuẩn chẩn đoán Đái tháo đường theo ADA 2020. Trên một bệnh nhân tiền sử đái tháo đường type 2 cách đây 3 năm đang điều trị 3 thuốc hạ đường huyết nghĩ nhiều đến nguyên nhân do kiểm soát đường huyết không đạt mục tiêu hoặc diễn tiến tự nhiên của bệnh.
- Biện chứng:
 - Biện chứng mạch máu nhỏ: bệnh nhân không thấy mờ mắt, nồng độ creatinin trong giới hạn bình thường nên chưa nghĩ đến biến chứng võng mạc, biến chứng thận trên bệnh nhân này. Đề nghị xét nghiệm 10 thông số nước tiểu để phát hiện sớm Albumin niệu
 - Biện chứng mạch máu lớn: bệnh nhân không có cơn đau đau ngực và ECG bình thường, không đau đầu. Cần xét nghiệm bilan lipid để chẩn đoán xơ vữa mạch vành, xơ vữa mạch máu não. Bệnh nhân không đau chân, đi lại bình thường, không thay đổi màu sắc da chi dưới nên chưa nghĩ đến biến chứng mạch máu ngoại biên trên bệnh nhân này..
 - Biện chứng thần kinh: bệnh nhân không đau chân, đi lại bình thường, không rối loạn cảm giác không thay đổi màu sắc da chi dưới nên chưa nghĩ đến biến chứng thần kinh trên bệnh nhân này
- Chẩn đoán phân biệt: bệnh nhân mệt mỏi, sụt cân nhiều trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến nguyên nhân cường giáp gây tăng chuyển hóa. Tuy nhiên, bệnh nhân không có các dấu hiệu đặc trưng của cường giáp như sợ nóng, tăng nhịp tim, lồi mắt, phù niêm nên chưa nghĩ đến nguyên nhân này. Cần làm xét nghiệm T3, FT4, TSH để loại trừ chẩn đoán.

- THA: bệnh nhân tiền sử tăng huyết áp cách đây 1 năm, hiện đang điều trị Amlodipine 5 mg/ngày, huyết áp lúc nhập viện có huyết áp 120/80 mmHg không kèm triệu chứng đau đầu, chóng mặt, cho thấy HA ở bệnh nhân này được kiểm soát tốt

Hiện tại, bệnh nhân không có các triệu chứng gợi ý tổn thương cơ quan đích như mờ mắt, giảm thị lực, đau ngực, khó thở. Tuy nhiên cần làm các xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm soi đáy mắt, siêu âm tim, BUN, ure, creatine, 10 thông số nước tiểu để phát hiện sớm những biến chứng này.

VIII. ĐỀ NGHỊ CẬN LÂM SÀNG

1. Cận lâm sàng thường quy: Công thức máu, điện giải đồ, AST, ALT, BUN, Creatinine máu, 10 thông số nước tiểu, XQ ngực thẳng, siêu âm bụng, ECG
2. Cận lâm sàng chẩn đoán; Glucose máu đói, HbA1C
3. Cận lâm sàng loại trừ chẩn đoán: T3, FT4, TSH
4. CLS theo dõi điều trị, tầm soát biến chứng đái tháo đường type 2: Glucose mao mạch, Bilan lipid, ABI, soi đáy mắt, Creatine niệu, Albumin niệu tại cùng 1 thời điểm cùng 1 mẫu.

IX. CẬN LÂM SÀNG ĐÃ CÓ

1. Công thức máu

Yêu cầu XN	Kết quả	Trị số tham chiếu	Đơn vị
WBC	9.8	4.0 – 12	K/uL
NEU	6.5	1.63 – 6.96	K/uL
NEU%	70	39.3 – 73.7	%
RBC	5.1	4.0 – 6.2	M/uL
HGB	11.2	11- 17	g/dL
Hct	40	37 – 52	%
PLT	313	150 – 450	K/uL

Công thức máu bình thường.

2. Sinh hóa máu:

Xét nghiệm	Kết quả	Trị số tham chiếu	Đơn vị
LDL_Cholesterol	1.29	< 4.1	mmol/L
HDL-Cholesterol	0.97	> 1.03	mmol/L
Triglyceride	2.3	< 2.25	mmol/L
Cholesterol	2.3	0.0- 6.2	mmol/L
AST	134	< 35	U/L
ALT	85	< 35	U/L
Ure	5.6	2.8- 7.2	Mmol/L
Creatine	67	58 - 96	umo/L
Glucose bất kì	17.4	4.1 – 5.9	umo/L
HbA1C	12.2	4.0 – 6.5	%

Bệnh nhân đái tháo đường 3 năm, đang dùng 3 thuốc hạ đường huyết, HbA1C và đường máu bất kì đều rất cao cho thấy bệnh nhân không được kiểm soát tốt cả đường huyết đói và đường huyết sau ăn.

Bệnh nhân có nồng độ Triglycerid cao 2.5 mmol/L, cho thấy có rối loạn lipid máu. Trên một bệnh nhân đái tháo đường cần kiểm soát tốt lipid máu để giảm nguy cơ xơ vữa, bệnh tim mạch và các biến chứng khác.

Nồng độ ure, creatinine nằm trong giới hạn bình thường, mức lọc cầu thận , cho thấy chưa có biến chứng trên thận.

Bệnh nhân có tăng men gan cao từ 2-3 lần, nghi ngờ một tình trạng viêm gan cấp. Nguyên nhân có thể do bệnh tự miễn, dùng thuốc, do virus hoặc viêm gan do rượu. Hỏi bệnh và tiền sử cho thấy bệnh nhân không có bệnh tự miễn hoặc uống rượu bia, tiền sử bản thân và người nhà không mắc các loại viêm gan B,C và gần đây bệnh nhân có uống nước lá không rõ loại, nên có thể nghĩ nhiều đến nguyên nhân bệnh nhân uống nước lá gây độc cho gan. Tuy nhiên, cần xét nghiệm HbsAg, Anti HCV để loại trừ chẩn đoán viêm gan do virus.

3. Miễn dịch

- HbsAg âm tính
- Anti HCV âm tính

Bệnh nhân không mắc viêm gan B, C cho nên nghĩ nhiều nguyên nhân gây viêm gan cấp là do uống nước lá không rõ loại gây độc cho gan.

4. Glucose mao mạch theo dõi (5h)

- Ngày 22/6 : 11.5 mmol/L
- Ngày 23/6: 11.7 mmol/L
- Ngày 24/6: 10.3 mmol/L
- Ngày 25/6: 11,9 mmol/L

Đường huyết đói của bệnh nhân chưa được kiểm soát tốt, cần tiếp tục nâng liều Insulin đến khi đạt mục tiêu.

5. Kết quả ECG:

- Nhịp xoang, đều, tần số 80 lần/phút
- Trục trung gian
- Sóng P: 0.09s, biên độ 2 mm
- Khoảng PR: 0.14s
- Phức bộ QRS: 0.10s
- Khoảng QT: 0.32s
- Không lớn nhĩ
- Chỉ số Sokolov Lyon < 35 mm

ECG chưa ghi nhận bất thường.

6. Kết quả X quang ngực thẳng:

- Hai trường phổi sáng
- Bóng tim trong giới hạn bình thường
- Ngấm vôi hóa quai động mạch chủ

7. Siêu âm tim

- Các lá van mềm mại, di động tốt

- Không rối loạn vận động vùng
- Chức năng tâm thu thất trái bảo tồn EF: 66%

8. Siêu âm bụng

- Gan nhiễm mỡ

9. Kết quả 10 thông số nước tiểu:

Bilirubin	Âm tính
Hồng cầu	10 ery/ul
Ketone	Âm tính
Bạch cầu	Âm tính
Nitrate	Âm tính
Protein	Âm tính
SG	1.010
pH	7

Bệnh nhân chưa thấy biến chứng tại thận của THA, đái tháo đường

X. CHẨN ĐOÁN CUỐI CÙNG

Đái tháo đường type 2, biến chứng rối loạn lipid máu - Viêm gan cấp do dùng thức uống không rõ loại.

XI. ĐIỀU TRỊ

1. Nguyên tắc điều trị

- Giảm các triệu chứng lâm sàng, đạt mục tiêu kiểm soát glucose máu
- Mục tiêu kiểm soát đường huyết:
 - HbA1c < 7%
 - Glucose máu đói: 4.4 – 7.2 mmol/L
 - Glucose máu sau ăn: < 10.0 mmol/L
- Đạt cân nặng lý tưởng
- Làm chậm xuất hiện các biến chứng cấp và mạn tính
- Giúp người bệnh có cuộc sống bình thường
- Điều trị bệnh kèm

2. Biện luận điều trị

– Về bệnh chính:

Mức độ kiểm soát chặt chẽ A1C: bệnh nhân có các yếu tố thỏa mãn để kiểm soát đường huyết một cách chặt chẽ gồm: tuổi, thời gian mắc bệnh ngắn, chưa xuất hiện biến chứng, kì vọng sống cao.

Bệnh nhân đái tháo đường type 2 cách đây 2 năm, hiện đã điều trị 3 loại thuốc hạ đường huyết nhưng không kiểm soát được glucose máu, HbA1C lúc vào viện 12.2%, glucose máu 17.4 mmol/L theo khuyến cáo của Hiệp hội Nội tiết lâm sàng Hoa Kỳ nên khởi trị Insulin, bắt đầu với Insulin nền tác dụng kéo dài, kết hợp duy trì Metformin với mục tiêu giảm A1C < 7% trong vòng 3 tháng. Theo nghiên cứu FINE Asia, khởi đầu bằng Glargine giúp kiểm soát HbA1c tốt hơn và ít hạ đường huyết hơn khi so sánh với NPH và detemir ở các bệnh nhân ĐTĐ type 2 châu Á. Vì vậy, khởi trị Insulin trên bệnh nhân này với Glargine 10 UI/ ngày.

Mục tiêu glucose máu đói 5.6-7.2mmol/l, lâm sàng bệnh nhân theo dõi glucose mao mạch 5h trong 3 ngày đầu điều trị từ 10.3-11.7 mmol/l (> 10 mmol/l) cần nâng thêm 4 UI 1-2 lần/tuần để đạt mục tiêu.

Xét nghiệm HbA1c lại sau 3 tháng

Phòng ngừa biến chứng tim mạch: Đối với bệnh nhân đái tháo đường trên 40 tuổi, rối loạn triglyceride cần dự phòng biến cố tim mạch bằng statin cường độ trung bình. Rosuvastatin liều 10mg được khuyến cáo sử dụng hàng ngày, mục tiêu Triglycerid < 1.7 mmol/L.

Điều trị triệu chứng ngứa cho bệnh nhân: điều trị triệu chứng bằng kháng Histamin H1: Loratadine 10mg

– Về bệnh kèm:

- Ngưng uống nước lá gây độc cho gan

- Thay đổi lối sống: hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia, nên uống nhiều nước, bổ sung vitamin ...
- Viêm gan điều trị hỗ trợ chức năng gan, giải độc gan

3. Điều trị cụ thể

- Điều trị không thuốc
 - + Tập thể dục đều đặn ít nhất 30p/ngày, 5 ngày/ tuần
 - + Đạt cân nặng lý tưởng: $CC*CC*22 = 54 \text{ kg}$
 - + Không sử dụng bất kì thuốc, thực phẩm thực uống không rõ thành phần
- Điều trị thuốc: (dựa trên thuốc hiện có tại bệnh viện)
 - + Insulin lantus 18 UI/ngày tiêm dưới da
 - + Metformin 500mg *01 viên uống
 - + Rosuvas Hasan 10mg * 01v/ngày, uống
 - + Sylimarin VCP 140mg *02 viên uống
 - + Lorastad 10mg * 01 viên uống

XII. TIỀN LƯỢNG- DỰ PHÒNG

1. Tiên lượng

- Tiên lượng gần: Trung bình

Bệnh nhân vào viện với triệu chứng ít rầm rộ của hội chứng tăng glucose máu, không có các biến chứng cấp như tăng áp lực thẩm thấu, toan lactic, sau khi đường huyết giảm thì triệu chứng cải thiện đáng kể, giảm mệt, tiểu bình thường cho thấy bệnh nhân đáp ứng với điều trị.

Tuy nhiên, glucose mao mạch sau 4 ngày điều trị chưa đạt được mức glucose đối mục tiêu, cho thấy Insulin chưa kiểm soát được đường huyết trong ngày, cần tiếp tục theo dõi chỉnh liều đến khi đạt mục tiêu.

- Tiên lượng xa: Dè dặt

2. Dự phòng:

- Giáo dục cho bệnh nhân phải tuân thủ các biện pháp dự phòng và điều trị, nhận biết các dấu hiệu của tăng đường huyết, hạ đường huyết
- Hướng dẫn cho bệnh nhân có lối sống phù hợp: không ăn đồ dầu mỡ, đồ ăn nhanh, rượu bia, uống nhiều nước, bổ sung các vitamin thiết yếu
- Duy trì BMI trong giới hạn bình thường
- Tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ